– இவர்களது நிலை சில மணி நேரங்கள் கடந்து செல்வதற்கு நிலையாக இருப்பார்கள் ஆனால் பயிற்சி பெற்ற நபர்களால் கண்காணிப்புகள் மற்றும் தொடர்ச்சியான வகைப்படுத்துதல் தேவைப்படுகிறது. அதை பொறுத்து மருத்துவமனையின் கவனிப்பு தேவையை அறிதல். சூழ்நிலையை பொறுத்து உடனடி கவனிப்பு முன்னுரிமையை பெறுகின்றார்.

பெரிய தீவிர நோய் அல்லது காயங்கள்; – திறந்த எலும்பு முறிவு,மார்பில் காயங்கள்

வகுப்பு III

(அவசர மில்லை) – பச்சை – குறைவான (அ) மிதமான

அனைத்து உயர் முன்னுரிமை பெற்ற நோயாளிகள் வெளியேறும் பொழுது, இந்நிலையில் காயமடைந்த நோயாளிகளுக்கு மருந்துவ கவனிப்பு தேவைப்படும் அல்லது கண்காணிப்பு தேவைபடாமலும் இருக்கலாம்.

நோயாளி/பாதிக்கப்பட்ட நபர் 2 மணி நேரம் தாமதமாக இடம்பெயர்ந்தும் சிகிச்சை மேற்கொள்ளலாம்.

சாதாரண/சிறிய காயங்கள், காயப்பட்டவர்கள், மூடிய எலும்பு முறிவு, சுளுக்கு, வலி.

வகுப்பு IV

(எதிர்பார்க்கும் நிலை) –கருப்பு எதிர்பார்க்கும்

கடுமையாக (அ) தீவிரமாக காயமடைந்தவர்கள் பின் இறந்து விடுவார்கள், ஒரு மணி நேரமோ (அ) ஒரு நாளோ இருக்க வாய்ப்புண்டு.

(அதிக உடல் தீ காயங்கள், தீவிர காயங்கள், உயிரை கொள்ளும் அளவிற்கு கதிர்வீச்சுகள்)

உயிருக்கு அச்சுருத்தலை ஏற்படுத்த மருத்துவ நெருக்கடியான சூழ்நிலையின் கிடைக்ககூடிய கவனிப்புகளை கொடுத்த போதிலும் அவர்கள் உயிர் பிழைக்க இயலாத நிலையாகும். (மாரடைப்பு, அதிர்ச்சி, தீவர தலை மற்றும் மார்பில் காயங்கள்)

பாதிப்பினை குறைக்க அவர்களை தனி பிரிவுகளுக்கு கொண்டு சென்று வலி நிவாரணி மாத்திரைகளை கட்டாயமாக கொடுக்கப்பட வேண்டும்.

இறந்துவிடுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்டது கடும் தலைக்காயம், உடல் முழுவதும் அடர்த்தியான தீக்காயம்.



9.10 பேரழிவுகளில் செவிலியரின் பங்கு

பேரழிவின் போது பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு குறுகிய, நடுத்தர, நீண்டகால சுகாதார தேவைகளை அறிந்து நெருக்கடியான நேரங்களில் பயனுள்ள வகையில் வழங்குதலாகும். அனைத்து நிலைகளிலும் உள்ள ஆபத்துகளை மதிப்பிடுதல், பல ஒழுங்குமுறை மேலாண்மை உத்திகள், பேரழிவு தயார் நிலை ஆகியவை உள்ளடங்கியவை ஆகும். (சர்வதேச செவிலியர் குழுமம் -2006)

பேரழிவுகளின் செவிலியரின் முக்கிய பங்கு

1. நிகழ்வின் அளவை தீர்மானிக்கவும்.
2. பாதிக்கப்பட்ட குழுக்களின் தேவையை வரையறை செய்தல்.
3. முன்னுரிமைகள் மற்றும் குறிக்கோள்களை உறுதிப்படுத்துதல்.
4. நடைமுறையில் நிகழக்கூடிய பொது சுகாதார பிரச்சனைகளை அடையாளம் காணுதல்.
5. அடையாளம் காணப்பட்ட தேவைகளான வள ஆதாரங்களின் தேவையை நிறைவேற்ற தீர்மானித்தல்.
6. மற்ற தொழிற்துறை பிரிவுகள், அரசு மற்றும் அரசு சாரா நிறுவனங்களுடன் ஒத்துழைக்க வேண்டும்.
7. கட்டளைகளை ஒன்றிணைக்கப்பட்டு தொடர்ச்சியாக பராமரித்தல்.
8. தகவல் தொடர்பு பரிமாற்றம்.

இந்நிகழ்வுகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளித்தல்

- அனைத்து அவசர பிரிவு அறை பார்வையிடுவதிலே 25% நபர்களை அடிப்படை முதலுதவி மற்றும் CPR சான்றிதழ்களின் வழியே தவிர்க்க இயலும்.

Nursing General_Tamil Ch-9.indd 196 14-06-2018 19:33:33